先评估睑缘，再按病因分类

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

所有干眼患者均评估睑缘

对所有已诊断为干眼的患者均应完善睑缘评估和相关疾病诊断。睑缘炎、 MGD 、闭合不全等可诱发或加重干眼；管理是长期、持续性过程。

2025 版 /2026 刊 p106 / PDF2

评估顺序与可并存分型

先评估睑缘结构异常，再看急性睑板腺炎、睑板腺囊肿等后部疾病，最后评估前部睑缘。分类依次考虑脂溢性、蠕形螨、葡萄球菌性睑缘炎及 MGD ；可合并 2 种及以上。

2025 版 /2026 刊 p106–107 / PDF2–3

按病因治疗，居家与院内配合

急性睑板腺炎和葡萄球菌性睑缘炎积极抗细菌治疗；螨虫性者除螨。轻中度睑缘炎首选居家治疗；居家效果不佳、依从性差或中重度者可配合院内治疗。

2025 版 /2026 刊 p107–108 / PDF3–4

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

门诊检查：病史、体征与辅助检查

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

病史与相关药物

问不适症状及持续时间、眼热 / 化学烧伤和眼睑手术史；关注酒渣鼻、甲状腺疾病、特应性皮炎、银屑病、移植物抗宿主病，以及抗组胺药、抗胆碱能药、异维 A 酸使用。

2025 版 /2026 刊 p107 / PDF3

体格与眼表检查

查视力、眼压及面部皮肤；评估倒睫、内外翻、闭合不全、瞬目，前后睑缘和睫毛根部；查泪河、泪膜破裂时间、结角膜、荧光素染色及角膜上皮 / 基质病变。

2025 版 /2026 刊 p107 / PDF3

辅助检查优先级

优先完善眼前节照相和睑板腺红外显影，记录睑缘、结角膜及腺体萎缩。条件允许再做分泌物刮片 / 培养、蠕形螨检测及激光扫描共聚焦显微镜检查。

2025 版 /2026 刊 p107 / PDF3

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

居家基础：清洁与除螨

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

睑缘清洁：溶液、频次及疗程

推荐 0.01% 次氯酸、睑缘清洁液 / 湿巾。葡萄球菌性者推荐 0.01% 次氯酸；脂溢性和 MGD 者推荐清洁液 / 湿巾去油脂。每日早晚各 1 次，持续 1 个月以上。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

除螨：成分、频次及疗程

建议含茶树油、 4- 松油醇或秋葵精油等眼部湿巾擦拭睑缘，每日 2 次（早晚各 1 次），一般 2~3 个月，以减少复发。具体成分浓度：原文未明确。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

除螨疗效不可只看虫数

综合螨虫数量、症状、袖套状分泌物 / 倒睫 / 乱睫等睫毛异常、睑缘炎症及睑板腺异常；不应仅以螨虫减少作为唯一疗效及治疗终点指标。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

热敷、冷敷与操作安全

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

MGD 热敷参数

热毛巾或一次性湿热治疗贴，温度 40~45 ℃，每次 10 min 以上，每日至少 1 次，建议坚持 2 周以上；之后可根据自身情况调整时长和频率。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

重炎症冷敷参数

冷敷适于睑缘炎症较重者：包冰毛巾或冷敷贴，约 10 ℃，持续 5~10 min 。炎症控制后可改为热敷，或冷热敷交替。冷敷每日次数：原文未明确。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

热敷与按摩安全

热敷时勿压迫眼球。热敷后可用指腹沿垂直睑缘方向轻柔按摩促进排出，注意力度；青光眼患者谨慎操作。观察症状、腺口、睑酯分泌、腺体缺失及脂质层厚度。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

院内治疗：按摩、清洁与 IPL

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

院内睑板腺按摩

不建议患者居家进行器械性睑板腺按摩。完成热敷或 IPL 后，表面麻醉剂 1~2 滴；用玻璃棒或按摩镊轻柔挤出睑酯，避免腺体损伤；建议每周 1 次，持续 1 个月以上，再个体化调整。

2025 版 /2026 刊 p108 / PDF4

院内深度清洁

表麻 1~2 滴；电解水润湿刷头，从低转速起、与患者沟通；鼻侧到颞侧匀速移动，重复 2~4 次。建议每 1~2 周 1 次，直至分泌物明显减少。

2025 版 /2026 刊 p108–109 / PDF4–5

IPL 防护与初始参数

清洁后使用遮光眼贴 / 眼罩；治疗上睑需内置眼盾。滤光片 590 nm ；原文光强度 10~16 J ，推荐初始 12~15 J ，按 Fitzpatrick 肤型选择并先试斑。原文单位为 J 。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

脉动与联合：参数和治疗顺序

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

热脉动 / 液脉动

维持睑缘 40~42 °C 并同步按摩；连接设备、自测、正确放置治疗头，实时监测，结束后查眼及皮肤。建议单次治疗为 1 疗程，再次治疗间隔依疗效个体化。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

光热脉动复合治疗

LED 波长 544 和 860 nm ，维持 40~42 °C ；加热眼睑持续 90 s ，需延长时评估后重置；不可夹睫毛，缓增压力并根据反馈调整。建议单次治疗，再次间隔个体化。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

IPL 联合按摩的顺序

推荐先完成 IPL ，再行睑板腺按摩；睑板腺囊肿患者按摩时避开囊肿区域，以免挤压损伤。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

药物、手术及随访边界

2025 版／2026 刊载 · 专家共识 · 干眼患者睑缘管理

药物：感染或难治 / 全身病变

睑缘细菌感染局部用敏感抗生素，如氧氟沙星眼膏、加替沙星凝胶；难治性或合并全身病可考虑口服阿奇霉素、多西环素、四环素，密切观察不良反应。具体剂量疗程未明确。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

手术适应情形

物理治疗效果不佳的 MGD 可考虑睑板腺探通；眼睑缺损积极修补以恢复形态；闭合不全必要时考虑睑缘缝合或融合手术。

2025 版 /2026 刊 p109 / PDF5

疗效复评及随访缺项

复评症状、睑缘、腺口、分泌物及除螨表现，依疗效调整。统一复诊间隔、量化停治阈值及正式风险分层：原文未明确。

2025 版 /2026 刊 p108–109 / PDF4–5

特殊人群与禁忌缺项

青光眼患者热敷后按摩需谨慎。儿童、孕哺期专门方案，各口服抗生素的禁忌、相互作用及完整 IPL 禁忌证清单：原文未明确，不据本共识补编。

2025 版 /2026 刊 p108–109 / PDF4–5

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

一页临床路径｜干眼患者睑缘管理

2025 版／2026 刊载 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 所有干眼患者：完成睑缘评估

先结构异常，再后部疾病，最后前部睑缘；分型可并存。优先照相＋腺体红外显影。按发现分别进入 2 、 3 或 4 。

2025 版 /2026 刊 p106–107

结构异常

2 有结构异常 → 结构 / 病因处理

眼睑缺损：积极修补；闭合不全：病因治疗及必要时睑缘缝合 / 融合。可与其他睑缘分型并存，合并者同时按 3/4 处理。

2025 版 /2026 刊 p107 、 109

轻中度 /MGD

4 轻中度 /MGD → 居家基础管理

清洁早晚各 1 次、持续 1 个月以上； MGD 热敷 40~45 °C 、每次 10 min 以上、每日至少 1 次、建议 2 周以上。重炎症可冷敷。

2025 版 /2026 刊 p108

3 有感染线索 → 按病原体治疗

急性睑板腺炎 / 葡萄球菌性：抗细菌治疗。螨虫性：除螨每日 2 次、一般 2~3 个月；疗效须同时看症状、体征及虫数。

2025 版 /2026 刊 p107–108

需升级

5 效果不佳 / 依从性差 / 中重度 → 院内

个体化选按摩、深度清洁、 IPL 或脉动；继续居家。联合时先 IPL 后按摩 / 热液脉动；囊肿按摩避开病灶。

2025 版 /2026 刊 p107–109

治疗后

复评

6 复评 → 继续、调整或升级

比较症状、睑缘、腺口及睑酯；除螨不以虫数为唯一终点。无效 MGD 可考虑探通。统一复诊间隔和停治阈值：原文未明确。

2025 版 /2026 刊 p108–109

跨行分支： 1→3 感染分型； 2→6 复评； 4→6 复评

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。